MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de primera infancia

La Nación y las provincias acuerdan estándares comunes para los centros de primera infancia, metas públicas por provincia de sala de 3 (del 55 % al 90 % al fin de la Fase II, y del 41 % al 85 % en los hogares más pobres) y de controles de salud, y la ejecución provincial y municipal con financiamiento nacional por fórmula.

Propuesta 76: Jardín, salud y nutrición desde que nacen
Cuándo: Fase I · año 1 (tras la sanción de la ley «Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia»)
Trámite: Acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias y la CABA, en el marco del Consejo Federal de Educación y del Consejo Federal de Salud. No requiere ley nacional (criterio B14; las transferencias las autoriza «Ley de financiamiento plurianual de la primera infancia»): el PEN lo aprueba por decreto y cada legislatura lo ratifica si su Constitución lo exige; rige desde la firma en lo que no requiera ratificación.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular de la autoridad de aplicación de la Ley N° [●] de financiamiento plurianual de la primera infancia y por el titular del Ministerio de Salud, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes».

Que la Ley N° 27.611 garantiza la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, y que la Ley N° 27.045 hizo obligatoria la sala de cuatro años y comprometió la universalización de la sala de tres años, sin fijar estándares detallados.

Que la Ley N° 26.233 regula los Centros de Desarrollo Infantil, y que es necesario acordar estándares comunes de personal y de espacio para los centros de primera infancia de todo el país.

Que los artículos 116 a 118 de la Ley N° 26.206 establecen al Consejo Federal de Educación como ámbito de concertación de la política educativa, y que el Consejo Federal de Salud es el ámbito de coordinación sanitaria entre la Nación y las provincias.

Que la Ley N° [●] fijó un piso presupuestario plurianual y dispuso que las transferencias a las jurisdicciones se instrumenten mediante un acuerdo federal con estándares y metas públicas por jurisdicción.

Que en 2024 asistía a sala de tres años el cincuenta y cinco por ciento (55 %) de los niños y niñas de esa edad, y el cuarenta y uno por ciento (41 %) en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos.

Que corresponde a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a sus municipios la ejecución de las políticas, y a la Nación fijar estándares comunes, financiar e informar.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan una política integral de primera infancia con cuatro componentes: a) los mil días de la Ley N° 27.611, con controles, suplementos nutricionales y vacunas al día; b) nutrición de calidad en comedores, jardines y centros de primera infancia, con educación alimentaria y prevención de la malnutrición por exceso; c) cuidado y educación inicial, con la universalización de la sala de tres años y centros de primera infancia que cumplan estándares comunes; y d) visitas domiciliarias de acompañamiento a la crianza en hogares vulnerables.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Distribución de responsabilidades. La Nación fija los estándares comunes junto con las jurisdicciones, financia por fórmula conforme la Ley N° [●] y su reglamentación, brinda asistencia técnica y publica la información. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejecutan las políticas en forma directa o por medio de sus municipios, mediante los convenios que celebren con ellos.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Estándares comunes de los centros de primera infancia. Los centros de primera infancia comprendidos en la Ley N° 26.233, cualquiera sea su dependencia, cumplen como mínimo: a) dirección a cargo de una persona con título docente de nivel inicial o título profesional afín; b) al menos una persona adulta con formación específica certificada en cada grupo, y capacitación anual de todo el personal; c) relaciones máximas de niñas y niños por persona adulta y superficie mínima por niño según la edad, que aprueba la Comisión de la cláusula undécima dentro de los ciento veinte (120) días de la firma y que no pueden ser menos exigentes que las vigentes en cada jurisdicción; d) alimentación conforme las guías alimentarias nacionales; e) verificación al ingreso y cada año de los controles de salud y del calendario de vacunación; y f) condiciones edilicias de seguridad e higiene. Los centros existentes se adecuan dentro de los tres (3) años de la firma.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Metas de sala de tres años. Las partes fijan como metas nacionales, en cumplimiento de la Ley N° 27.045, llevar la cobertura de la sala de tres años del cincuenta y cinco por ciento (55 %) al noventa por ciento (90 %) de las niñas y los niños de esa edad al 10 de diciembre de 2030, y del cuarenta y uno por ciento (41 %) al ochenta y cinco por ciento (85 %) en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos, en camino a la universalidad.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Metas de controles de salud y vacunas. Las partes fijan como meta que el cien por ciento (100 %) de las niñas y los niños de cero a cinco años tenga sus controles de salud y su calendario de vacunación al día, registrados en el registro nominal de la primera infancia.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Metas por jurisdicción. Cada jurisdicción fija, dentro de los noventa (90) días de su adhesión, sus metas anuales para los años 2028 a 2031 de cobertura de sala de tres años, en total y en el veinte por ciento (20 %) de hogares de menores ingresos, y de controles y vacunas al día, consistentes con las metas de las cláusulas cuarta y quinta y con su propio punto de partida. Las metas son públicas y se revisan cada año.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Ejecución provincial y municipal. Las jurisdicciones abren las vacantes, gestionan o habilitan los centros de primera infancia, organizan las visitas domiciliarias y garantizan los controles de salud, por sí o por medio de sus municipios. Habilitan y supervisan los centros de gestión privada, comunitaria o municipal conforme los estándares de la cláusula tercera.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Financiamiento. La Nación transfiere a cada jurisdicción los recursos que le correspondan por la fórmula de la Ley N° [●], mediante el convenio bilateral previsto en su artículo 9°. Las jurisdicciones mantienen, en términos reales, el gasto propio que destinaban a las políticas de este Acuerdo en el año anterior a su firma, de modo que los recursos nacionales lo complementen y no lo reemplacen.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Prioridad por pobreza infantil. Las vacantes nuevas financiadas con recursos nacionales se abren en primer lugar en las localidades con mayor pobreza de cero a catorce años, conforme la Ley N° [●] y su reglamentación.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Información y protección de datos. Las jurisdicciones suministran al registro nominal de la primera infancia y a los sistemas nacionales de información educativa y sanitaria los datos necesarios para medir las metas, con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326 y de la identidad de niñas y niños conforme el artículo 22 de la Ley N° 26.061.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Comisión Federal de Seguimiento. Créase la Comisión Federal de Seguimiento de la Primera Infancia, integrada por un representante de la autoridad de aplicación de la Ley N° [●], uno del Ministerio de Salud, uno del área nacional de educación y uno por cada jurisdicción firmante. La Comisión aprueba los estándares de la cláusula tercera, inciso c), consolida y publica las metas de cada jurisdicción, y se reúne al menos dos (2) veces por año. Sus integrantes no perciben remuneración por esa función.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Consejos federales. Las partes promueven que el Consejo Federal de Educación apruebe por resolución las metas de sala de tres años de cada jurisdicción, y que el Consejo Federal de Salud acuerde las metas de controles y vacunas, conforme este Acuerdo.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicidad. La autoridad de aplicación de la Ley N° [●] publica cada año, junto con el informe del artículo 10 de esa ley, el avance de cada jurisdicción en las metas de este Acuerdo.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Adhesión. Las jurisdicciones que no lo suscriban en el acto de firma pueden adherir en cualquier momento mediante nota de su gobernador o Jefe de Gobierno dirigida a la autoridad de aplicación de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2031, y se renueva por períodos de cuatro (4) años salvo denuncia de alguna de las partes con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Controversias. Las partes resuelven de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Ratificación. El presente Acuerdo no requiere aprobación por ley nacional, porque no compromete créditos de ejercicios futuros, no modifica leyes nacionales ni afecta la coparticipación federal de impuestos: las transferencias nacionales ya están autorizadas por la Ley N° [●]. El Poder Ejecutivo nacional lo aprueba por decreto y lo publica en el Boletín Oficial, y cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando así lo exija su Constitución. Rige entre las partes desde su firma en todo lo que no requiera ratificación.